

Exantemas virales clásicos (sarampión, rubéola, varicela y escarlatina)

1. Introducción y relevancia clínica

Los **exantemas virales clásicos** constituyen un grupo de enfermedades infecciosas transmisibles, caracterizadas por erupciones cutáneas típicas, de curso autolimitado y alta contagiosidad. Aunque la mayoría son benignas, algunas pueden provocar **complicaciones graves** o tener **importancia epidemiológica**, especialmente en población infantil, embarazadas e inmunocomprometidos.

En Chile, gracias a la implementación del **Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI)**, las enfermedades exantemáticas prevenibles como el **sarampión** y la **rubéola** han sido controladas, sin circulación autóctona desde hace más de una década. No obstante, los **casos importados** o los **brote en personas no vacunadas** continúan representando un riesgo.

Por su frecuencia histórica, impacto y relevancia epidemiológica, los exantemas clásicos de mayor importancia clínica son:

- **Sarampión** (virus del sarampión, género *Morbillivirus*)
- **Rubéola** (virus de la rubéola, género *Rubivirus*)
- **Varicela** (virus varicela-zóster, familia *Herpesviridae*)
- **Escarlatina** (*Streptococcus pyogenes*, toxina eritrogénica)

Estos cuadros son de **gran valor diagnóstico** en medicina general y en el **EUNACOM**, donde suelen presentarse casos clínicos orientados al reconocimiento de patrones exantemáticos, medidas de aislamiento y manejo de complicaciones.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

Sarampión

El **virus del sarampión** es un *paramixovirus* que se transmite por **vía aérea**, a través de gotitas y aerosoles, con un poder de contagio extraordinariamente alto (más del 90 % en susceptibles).

El virus penetra por la mucosa respiratoria y se replica en el epitelio nasofaríngeo, produciendo viremia con diseminación a ganglios linfáticos, piel, conjuntiva y otros órganos.

El **exantema** no es un efecto directo del virus, sino una manifestación **inmunológica** mediada por linfocitos T frente a células infectadas en los capilares dérmicos.

Rubéola

Causada por el **virus de la rubéola**, un *togavirus* de ARN, que se transmite por secreciones respiratorias.

La viremia se produce 5 a 7 días después de la exposición y provoca infección en piel y ganglios linfáticos. Su forma congénita se origina por transmisión transplacentaria durante el embarazo, generando el **síndrome de rubéola congénita**, una de las causas prevenibles de sordera y malformaciones fetales.

Varicela

El **virus varicela-zóster (VZV)**, un herpesvirus humano, se transmite por gotitas o contacto directo con las lesiones cutáneas.

Tras la infección primaria (varicela), el virus queda **latente en los ganglios sensoriales** y puede reactivarse años después como **herpes zóster**.

El exantema se produce por replicación viral en la piel y reacción inflamatoria secundaria, originando las típicas lesiones vesiculares “en diferentes etapas evolutivas”.

Escarlatina

A diferencia de las anteriores, la **escarlatina** es una enfermedad **bacteriana**, causada por el *Streptococcus pyogenes* productor de **toxinas eritrogénicas**.

La toxina induce una reacción inmunológica que afecta la piel y mucosas, desencadenando el exantema característico.

Aparece como complicación de una **faringoamigdalitis estreptocócica**, y su tratamiento adecuado es fundamental para prevenir fiebre reumática.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

Sarampión

El período de incubación dura entre 8 y 12 días.

El cuadro comienza con un **pródromo** de fiebre alta, tos seca, coriza y conjuntivitis, conocido como el “complejo de los tres C”: *cough*, *coryza*, *conjunctivitis*.

Durante este período aparece un signo patognomónico: las **manchas de Koplik**, pequeños puntos blanquecinos en la mucosa yugal, opuestos a los molares, con halo eritematoso.

Posteriormente, se desarrolla un **exantema máculo-papular** que inicia detrás de las orejas y se extiende en sentido céfalo-caudal hasta cubrir todo el cuerpo.

El exantema es confluyente, no pruriginoso, y al resolverse deja una fina descamación.

Entre sus **complicaciones** destacan la **otitis media**, la **neumonía viral o bacteriana secundaria** y la **encefalitis postinfecciosa**. La **panencefalitis esclerosante subaguda**, aunque rara, puede aparecer años después.

Debe diferenciarse de rubéola, mononucleosis infecciosa, dengue o reacciones medicamentosas.

Rubéola

Tiene un período de incubación de 14 a 21 días.

El cuadro clínico se caracteriza por fiebre baja, malestar, **adenopatías retroauriculares, cervicales y occipitales** y un exantema rosado tenue, no confluyente, que se inicia en la cara y se extiende rápidamente al tronco y extremidades, durando aproximadamente 3 días.

En mujeres adultas es frecuente la presencia de **artralgias o artritis transitorias**.

En embarazadas, la infección durante el primer trimestre puede causar **síndrome de rubéola congénita**, con sordera neurosensorial, cataratas y cardiopatías congénitas.

Debe diferenciarse de sarampión (más grave y con manchas de Koplik), escarlatina leve, eritema infeccioso o exantemas por fármacos.

Varicela

Su período de incubación oscila entre 10 y 21 días.

El pródromo incluye fiebre moderada, malestar y anorexia.

Posteriormente aparece un **exantema polimorfo pruriginoso** con lesiones en distintas etapas evolutivas: máculas, pápulas, vesículas (“en gota de rocío sobre pétalo de rosa”), pústulas y costras.

Se distribuye predominantemente en el **tronco y cara**, con menor afectación de extremidades (distribución centrípeta).

Las mucosas orales y genitales también pueden afectarse.

Las **complicaciones** incluyen sobreinfección bacteriana de las lesiones (por *S. aureus* o *S. pyogenes*), neumonía, cerebelitis y encefalitis. En niños sanos suele ser autolimitada, pero en inmunodeprimidos y adultos puede ser grave.

Debe distinguirse de impétigo ampolloso, síndrome mano-pie-boca o infecciones diseminadas por herpes simple.

Escarlatina

Tiene un período de incubación corto, de 2 a 5 días.

El cuadro inicia con **fiebre alta, odinofagia intensa y malestar general**.

Poco después aparece un **exantema eritematoso difuso, finamente puntiforme, con textura áspera**, descrita clásicamente como “piel de lija”.

El eritema comienza en cuello y tronco, extendiéndose al resto del cuerpo, respetando la zona peribucal, lo que genera el **signo de Filatov**.

La lengua se torna inicialmente blanca con papilas prominentes (“lengua en fresa blanca”) y luego rojo brillante (“lengua aframbuesada”).

Tras la resolución, ocurre una **descamación laminar** de palmas y plantas.

Las complicaciones incluyen **fiebre reumática aguda, glomerulonefritis postestreptocócica** y, más raramente, **abscesos periamigdalinos o celulitis**.

Debe diferenciarse de rubéola, sarampión y reacciones medicamentosas.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Sarampión y rubéola

El diagnóstico es principalmente **clínico**, pero debe confirmarse por **laboratorio** en todo caso sospechoso por razones epidemiológicas.

Se utilizan pruebas serológicas (detección de IgM específica) o **PCR viral** en muestras de orina o secreciones respiratorias.

Ambas son enfermedades de **notificación obligatoria inmediata** al Ministerio de Salud (categoría I).

En casos sospechosos, se debe indicar aislamiento respiratorio por 4 días desde la aparición del exantema.

Varicela

El diagnóstico es clínico en la mayoría de los casos, basado en la morfología y cronología de las lesiones.

En casos atípicos o inmunocomprometidos puede confirmarse mediante **PCR para virus varicela-zóster** o inmunofluorescencia directa.

No se requieren exámenes de rutina en pacientes inmunocompetentes.

Escarlatina

El diagnóstico es clínico, apoyado por la demostración del agente causal mediante **test rápido de antígeno estreptocócico** o **cultivo faríngeo positivo para Streptococcus pyogenes**.

El hemograma suele mostrar leucocitosis con neutrofilia y desviación a la izquierda.

La detección temprana y tratamiento antibiótico previenen complicaciones inmunológicas.

5. Tratamiento (según Guías MINSAL y OMS 2023–2024)

Sarampión

No existe tratamiento antiviral específico.

El manejo se basa en el **tratamiento sintomático**, control de la fiebre y adecuada hidratación.

La **administración de vitamina A** ha demostrado reducir la mortalidad y las complicaciones respiratorias o neurológicas, especialmente en niños.

Se recomienda dar una dosis de 100.000 UI en menores de un año o 200.000 UI en mayores.

El paciente debe mantenerse en **aislamiento respiratorio** durante al menos 4 días desde la aparición del exantema.

Como profilaxis postexposición, se puede administrar la **vacuna SRP** dentro de las 72 horas o **inmunoglobulina específica** en inmunodeprimidos o embarazadas susceptibles.

Rubéola

El tratamiento es solo sintomático, con reposo, hidratación y antipiréticos.

No hay antiviral específico.

En embarazadas expuestas, debe realizarse **test serológico para rubéola IgM e IgG**, y derivar a infectología o medicina materno-fetal.

La **prevención** mediante vacunación (SRP) sigue siendo la estrategia más efectiva y fundamental en salud pública.

Varicela

El tratamiento en niños inmunocompetentes es sintomático: antipiréticos (preferir paracetamol), antihistamínicos orales y medidas locales como baños tibios y uñas cortas.

Nunca se debe usar aspirina, por riesgo de **síndrome de Reye**.

El **aciclovir** está indicado en casos moderados o graves, inmunodeprimidos, embarazadas o adultos mayores.

Se administra a dosis de 20 mg/kg/dosis cada 6 horas por 5 días (máximo 800 mg por dosis).

En casos complicados o inmunocomprometidos, puede requerirse aciclovir intravenoso.

El aislamiento se mantiene hasta que todas las lesiones estén en fase de costra.

Escarlatina

El tratamiento es **antibiótico**, con el objetivo de erradicar el estreptococo y prevenir complicaciones no supurativas.

El fármaco de elección es la **penicilina benzatina intramuscular en dosis única o amoxicilina oral por 10 días**.

En pacientes alérgicos se puede usar eritromicina o azitromicina.

Además, se indican analgésicos y antipiréticos.

Los contactos estrechos no requieren profilaxis antibiótica, salvo en brotes institucionales.

6. Complicaciones y pronóstico

Las complicaciones del **sarampión** incluyen otitis media aguda, neumonía viral o bacteriana y encefalitis postinfecciosa. En casos raros, puede aparecer una panencefalitis esclerosante subaguda años después de la infección.

La **rubéola** cursa de manera benigna en el adulto sano, pero su complicación más grave es el **síndrome de rubéola congénita**, que puede causar sordera, cataratas y cardiopatías fetales.

La **varicela**, aunque generalmente autolimitada, puede complicarse con sobreinfección bacteriana, cerebelitis o neumonía, especialmente en adultos, embarazadas o inmunodeprimidos.

La **escarlatina** puede derivar, si no se trata, en fiebre reumática o glomerulonefritis postestreptocócica.

En general, el pronóstico es excelente en pacientes inmunizados o tratados a tiempo.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. El sarampión se caracteriza por el pródromo con fiebre, tos, coriza, conjuntivitis y las **manchas de Koplik** en mucosa oral.
2. La rubéola dura 3 días y se acompaña de **adenopatías retroauriculares**.
3. En varicela, las lesiones cutáneas se encuentran **en diferentes etapas evolutivas**.
4. La escarlatina muestra **piel de lija, lengua aframbuesada y respeto del área peribucal**.
5. La administración de **vitamina A** disminuye complicaciones en sarampión.
6. La **penicilina** sigue siendo el tratamiento de elección en escarlatina.
7. En varicela, **nunca usar aspirina** por riesgo de síndrome de Reye.

Errores frecuentes:

- Indicar antibióticos en varicela no complicada.
 - No notificar casos sospechosos de sarampión o rubéola.
 - Confundir rubéola con reacciones a medicamentos.
 - No indicar aislamiento respiratorio en sarampión.
 - Omitir la administración de vitamina A en niños hospitalizados por sarampión.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Los **exantemas virales clásicos** tienen patrones clínicos distintivos y son altamente contagiosos.
2. El **sarampión** presenta **manchas de Koplik** y exantema céfalo-caudal; la **vitamina A** reduce complicaciones.
3. La **rubéola** causa adenopatías retroauriculares y riesgo de **síndrome congénito** en gestantes.

4. La **varicela** presenta lesiones en distintos estadios evolutivos; usar aciclovir solo en casos de riesgo.
5. La **escarlatina** es bacteriana y se trata con **penicilina**, evitando complicaciones reumáticas.
6. La **vacunación SRP y VVZ** son medidas preventivas clave en salud pública.
7. En **EUNACOM**, la clave está en reconocer el **patrón exantemático característico** y su **manejo específico**.